

自体心理学：理解和防治抑郁症的新视角*

张璇¹ 王申连²

摘要：从自体心理学的理论视角出发，探讨抑郁症的发生、预防及治疗新路径。在成因方面，抑郁源于早期自恋需求未得到充分满足而形成的脆弱、缺陷性自体结构；在预防方面，家庭作为关键的“自体客体”环境，养育者的共情性回应、良性亲子互动及适度延迟满足有助于统整、内聚性自体的形成；在治疗方面，咨询师应在良性治疗关系的基础上激活患者的自体客体移情，通过修复其自体缺陷，从而增强患者的自体感。自体心理学为抑郁症提供了更具人文温度的理解和防治视角，未来可强化该模型下的系统性研究，以进一步提升抑郁症的防治效能。

关键词：自体心理学，自体，自体客体，抑郁症

中图分类号：R-05 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-0772(2025)12-0053-05

DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2025.12.11

Self Psychology: A New Perspective for Understanding and Preventing/Treating Depression ZHANG Xuan¹, WANG Shenlian². 1. Center of Mental Health Education and Guidance, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China; 2. Institute of Mental Health, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 210017, China

Abstract: From the theoretical perspective of self psychology, this paper explores the onset, prevention, and new treatment pathways for depression. In terms of etiology, depression originates from a fragile and defective self-structure formed due to unmet early narcissistic needs. In prevention, as a critical "selfobject" environment, the family contributes to the formation of an integrated and cohesive self through caregivers' empathic responsiveness, positive parent-child interactions, and appropriate delayed gratification. In treatment, therapists should activate clients' selfobject transference based on a healthy therapeutic relationship, repairing their self-deficits to enhance their sense of self. Self psychology provides a more humanistic perspective for understanding, preventing, and treating depression. Future research could strengthen systematic studies under this model to further improve the efficacy of depression prevention and treatment.

Key Words: self psychology, self, selfobject, depression

抑郁症是一种在全球范围内普遍存在的精神障碍，又称抑郁障碍，是以持续性的情绪低落、自我价值感低、兴趣减退或丧失，并伴有异常的躯体症状和认知改变等^[1]为主要特征的一类心境障碍，严重影响个体的生活、学习和工作等方面的社会功能。有研究表明，我国成人抑郁症的终身患病率为 6.8%^[1]，青少年的抑郁症患病率已达 15%~20%^[2]，抑郁症不仅损害个人的身心健康，致使个体出现失眠和进食障碍等问题，甚至会造成自伤、自杀等严重问题^[3-4]。由于抑郁症的发病率和自杀率较高，且具有高复发

率和难治疗等特点^[5-6]，给患者、家庭和社会造成了沉重的负担。有关抑郁症的相关研究一直成为各国重点关注的公共卫生问题。

抑郁症的病因和发病机制比较复杂，目前尚未完全明确，有关抑郁症形成的原因也通常是从生物学因素、心理因素和社会因素进行解释，并被逐渐认为是生物、心理和社会因素相互作用的结果。由于抑郁症发病机制的复杂性，也形成了抑郁症治疗方式的多元化。目前针对抑郁症的治疗主要有药物治疗、物理治疗和心理治疗^[5]，其中，心理治疗中的认知行为疗法(cognitive behavioral therapy, CBT)、人际关系疗法(interpersonal psychotherapy, IPT)和行为激活疗法(behavioral activation therapy, BA)等主流心理治疗方法^[7-8]强调对抑郁症患者进行认知层面的修正和行为功能的改善，却较少关注患者的内在主观体验，并且对个体因早期创伤或人格障碍引发的抑郁症治疗也非常有限。有学者建议将抑郁症分为内向型和无关联型两类^[9]，不管是以内疚、自我评价低为主要特征的内向型抑郁，还是以高敏感性、空虚和羞耻为主要特征的无关联型抑郁^[10]，都体现了个人主观体验中的负性感受，而这些负性

* 基金项目：2025 年南京工业大学党建与思想政治教育研究课题(SZ20250324)；2023 年江苏省教育科学“十四五”规划重点课题(B/2023/01/08)

1. 南京工业大学心理健康教育指导中心 江苏南京 211816

2. 南京晓庄学院心理健康研究院 江苏南京 210017

作者简介：张璇(1992—)，女，硕士，助理研究员，研究方向：心理健康教育。

通信作者：王申连(1984—)，男，博士，教授，研究方向：儿童心理发展与心理健康、理论心理学、心理学史。

E-mail: wang_shenlian@163.com

的主体体验会严重影响个人的身心功能和社会功能^[11-12]。因此,对抑郁症的心理治疗也应重视患者本人的主观体验,对其内在精神世界进行更多深入性的理解,通过疗愈个人内心体验性的“创伤”进而帮助患者的人格成长。

自体心理学作为精神分析的一个重要理论分支,是由科胡特^[13]在 20 世纪 70 年代对自恋型人格障碍的治疗与探讨基础上提出的一类理论体系,该理论站在对人类充满同情的人文立场上来理解人性,重视对人类自我价值的理解和探索,具有浓厚的存在主义色彩。在探究人的存在本质中,认为自体是人类体验的核心,健康的自体具有空间上的内聚性和时间上的流动性^{[14]48},内聚性自体的人能够体验到强烈的自我价值感和自我存在感。同时,该理论关注早期成长环境对个体心理的影响以及心理缺陷模式的探讨,并认为精神障碍(如抑郁症)往往源于自体的变形、衰弱或者结构的缺陷,个体的抑郁、低自尊等心理病理与其自体连贯感的发展不足有关。由此,自体心理学理论认为治疗的焦点并非患者的功能问题,而更应关注患者作为一个人所体验到的内在精神世界——自体感的问题,强调可以通过修复患者的自体结构缺陷,进而帮助患者产生社会人际的适应性结构,提升个体的自尊、自我价值和意义感,从而使其能够更好地应对当下的生活。由于抑郁症的发生与个体早期成长环境因素有较大关联^[15],并且抑郁症通常以低自尊、低自我价值和无生活意义感等主观体验为核心症状,因此,精神分析中的自体心理学取向可能成为理解抑郁症的新视角。本文试图从自体心理学的理论出发,阐述抑郁症的发生过程,以期对抑郁症患者的内在主观体验进行深入系统的描述和分析,并为抑郁症的早期预防和临床治疗提出一定的合理化建议。

1 自体缺陷与抑郁症的发生

自体心理学认为,个体在早期发展中的自恋需求(如被认可、被共情的需求)未得到充分满足,可能形成脆弱性、缺陷性的自体结构(即自体缺陷)。这种自体缺陷被视为个体心理病理的核心根源,常表现为自尊心显著低下、情绪调节功能紊乱、人际关系功能受损等典型症状。根据症状的不同,自体心理学将人格分为神经质、自恋疾患和精神病三大类。在该理论的病理模型视角下,自恋疾患人格障碍的个体在自体感上具有不稳定和不统整性,并以低自尊、空虚、无意义和无聊感等为主要表现^{[14]90},而这些也正是抑郁症患者在主观体验上的主要表现。因此在自体心理学病理模型下分析抑郁症,有利于揭示抑郁症的发生过程,并加深对抑郁症患者内在体验的理解。

1.1 自恋与抑郁症

自体心理学认为,自体作为体验性的自我,是一个人精神世界和自我功能的核心,它不仅是个体对自身存在的认知,更是一种关乎自我价值、存在意义及生命连续性的深层体验。因此,健康的自体(以统整性和内聚性为主要特征)会让个体感受到高度的自我价值感和实在的自我存在感,并能够保障个体健康发展和发挥其应有的社会功能。

而不健康的自体会令个体体验到低自我价值和无意义感,并影响其各项功能的发挥。

在自体的形成和发展过程中,个体会表现出自恋这一正常现象,能否拥有成熟的自恋成为判断个体心理健康与否的关键^[16]。个体在出生时的全能自恋是一种虚弱的自体,如果自恋发展的需要成长过程中被外在环境及周围的人同调和良好的回应(如反馈、确认),虚弱的自体便会逐渐得到夯实并发展成为由镜映自体、理想化自体 and 孪生自体构成的核心自体,这一健康的核心自体具有良好的调节能力,可以赋予个人价值感和胜任感,即使遇到挫折和失败,藉由自体的稳定和韧性也会令个体恢复活力和胜任状态。但如果个体在发展中,自恋需要未被满足(如父母、照顾者或者重要他人对个体的忽视、无回应或贬低),会造成个体的自体感出现某种断裂,形成自体结构缺陷,即表现为自恋疾患。通常,自恋疾患人格的自体是脆弱的、不健康的,具有这类自体的个人会呈现出紊乱的自体关注,难以调节自信和自尊,极易形成自卑、无价值感和无意义感等自恋抑郁问题。

抑郁症患者通常表现出严重的自体感不足和自体功能受损问题^[17],即自恋疾患人格障碍的问题。从自体心理学理论看来,当个体在成长中的镜映需要、理想化需要或孪生需要被不同程度的抑制,即个体的自恋发展需要未获得很好的滋养时,会形成结构缺陷的自体,这种结构缺陷的自体会影响个体在认知、情绪和行为方面的调节功能,因此,个体会出现思维缓慢、情绪低落以及意志活动减退等抑郁症的核心症状,尤其在情绪体验上,个体常常感受到强烈的自我否定、低价值感和无意义感,这些进一步影响了其身心功能和社会功能,也使得抑郁症患者经常会在人际关系中体验到较低水平的社会支持和强烈的孤独感^[18]。对于抑郁症患者经常体验到的无力和能量耗竭感的原因,也在于自我在抵御虚弱自体的过程中,力比多为了维持濒临塌陷的心理结构(自体)而不断被耗竭的结果。

1.2 自体客体经验与抑郁症

科胡特认为个体的发展不是源自生物属性的内驱力,而是源自人际关系^[19],自体并不单独存在,而永远要在自体客体的环境中被谈及。自体客体并非实实在在的人或者物,而是个体获得的被他人理解自体需求的、融合性的、共鸣性的情感体验。自体客体能否满足个体的自恋需要会影响自体的发展及其功能^[20]。当外在环境给予理解和回应这种需要后,个体会产生自体客体经验,这种经验有助于其形成稳定、统整和内聚性的自体,个体会表现出旺盛的活力与生命力,在人际关系中也更为自信。但如果外在环境持续性回应错误则会造成个体的创伤体验,导致个体的自恋发展受到阻碍,体验到自我否定和生命的无价值。

对于抑郁症患者而言,通常能发现其在成长早期会经历较低质量的人际关系^[15],抑郁的人际关系模式认为,不良的人际关系,尤其是不良的家庭关系是引发和维持抑郁的关键因素^[21]。有研究表明,低响应度、隔离性的家庭是

造成个体抑郁、焦虑和攻击性等内外化行为的重要原因^[22]。当个体在低回应性、低支持度和低共鸣性的人际环境中生活，尤其是在不良的家庭养育环境中成长时，个体会体验到较少的自体客体经验，这些不被理解的感受和经验不仅不能支撑凝聚性自体的发展，反而可能会造成与羞耻感有关的创伤性情感，这种情感通常与个体的自我价值感紧密相关。因此，自体客体经验的不足会损伤个体自尊心和自信心的建立，以及个体对生命意义和幸福感的体验，最终导致抑郁的发生。而患有抑郁症的个体也经常会采取情感隔离或者压抑的应对方式，封锁自己的情感世界，甚至很难体验到自身的内在情感^[23]，这进一步切断了其与外在世界进行有效交流与获得情感共鸣的机会。因此，从个体的自体客体经验是否得到满足这一角度，或许是理解和治疗抑郁症的一个关键点。

1.3 创伤性挫折与抑郁症

在科胡特自体心理学视角下，自体客体的需要未被满足会对个体造成挫折，并影响其自体发展。但并非所有的挫折都会带来消极的结果，其中，“恰好的挫折”是一种对个人成长有益的挫折，它可以在不造成创伤的情况下促使自体客体功能通过转变性内化（或蜕变性内化）的作用形成健康的、适应性的自体结构。“不含敌意的坚决，不含诱惑的深情”其实是对“恰好的挫折”较为委婉的一种表达，早期关系中“恰好的挫折”可以坚固个体的人格结构，使个体不断地体验、觉察和修复自体客体需求，从而增强自体内聚力，帮助个体走向成熟与自信。

但是，如果个体的自体客体需要长期得不到满足（被拒绝、忽视或曲解）或者被抑制，便会形成创伤性挫折。这类挫折会将个体的镜映需要（夸大自体）或理想化需要压抑在潜意识中，造成水平分裂或者垂直分裂的防御，引起个体的自体心理结构缺陷，最终使个体以各种自恋匮乏症状的形式表现出来，如情绪低落、无价值感、无意义感等。有相关研究表明，儿童期的创伤经历与抑郁症有较大关联^[24]，尤其是早期的情感虐待和被忽视这两种创伤经历与个体成年后罹患抑郁症的相关性最强^[25]。对于抑郁症患者而言，长期不被理解、曲解和忽视的早期成长环境意味着其自体发展的自体客体需要（渴望被抚养者欣赏、认可的镜映需要，寻求被安抚、笃定的理想化需要，以及期望感受相似性、亲切感的孪生需要）很难获得真正满足，恰到好处的挫折自然难以发生，这样的不良情境（创伤性挫折）势必会抑制个体的自体客体经验发展及其功能性发挥，在此基础上形成的结构缺陷自体就会以情绪低落、低自尊和无价值等抑郁症状的形式表现出来。并且，创伤性挫折发生的时间越早、时间越长、程度越严重，造成的自体心理结构缺陷情况越严重，即自恋疾患人格障碍越严重^[26]，个体表现的抑郁症状也更为严重。

2 自体客体与抑郁症的预防

根据自体心理学理论，自体客体指的是个体在发展过程中，将他人、无生命客体或抽象概念体验为自体需求延

伸的内在心理表象。这些表象通过提供镜映（价值确认）、理想化（力量获取）、孪生（共鸣相似性）三种核心功能，满足个体的自体客体需求，从而支撑自体结构的统整性。这些自体客体在心理结构中并非单独存在，需要通过转变内化作用逐渐成为个体自体结构的一部分。因此，自体心理学理论关注个体与他人的互动关系对其自体发展的影响，尤其是早期家庭关系对个人身心健康的影响。有关抑郁症的病因学研究发现，相较于遗传、神经免疫等因素对抑郁症的影响，家庭环境、父母养育等外在环境因素对抑郁症的影响更大^[5]。家庭作为关键的“自体客体”环境，在帮助个体获得自我确认和稳定感，从而发展出健康的自体中发挥重要作用。因此，从自体心理学的理论视角提出相应的抑郁症早期预防建议具有一定的现实意义。

2.1 提供积极的共情性回应

对个人而言，自体从“夸大自体”成长为“内聚性自体”的过程，养育者（父母）在这个过程中对孩子共情、同调（尊重、理解和接纳的积极回应）起着重要媒介作用^[27]。孩子自小渴望获得养育者（父母）的关注、肯定和关心，当养育者经常以共情-内省的态度对待孩子时，孩子的夸大自体和理想化自体的需要便得到了愉悦的满足，这些需要的满足可以帮助孩子增强内在的安全感与自信心，即孩子的自体感得到很好的支持。即使孩子在未来遭受一定的挫折与伤害，也能够做到快速回弹和自我安抚，并在短时间内恢复到自信的感觉。但如果养育者长期无法对孩子进行共情或同调（如经常被父母忽视和曲解），失去重要他人以及其提供的“自体客体”功能会让孩子很难相信这个世界是美好的，自己是可以得到滋养的，孩子的自恋会受到损伤，故而极易陷入自我否定和情绪痛苦中，令个体变得情感淡漠、嗜睡、对生活感到空虚和失去活力，最终以抑郁的状态呈现^[28]。因此，在家庭环境中，孩子养育者（父母）应重视对孩子的主观感受进行共情性理解，即站在孩子的视角去理解和回应孩子渴望被欣赏、接纳以及获得力量感的需要，以增强孩子的自体感，避免因共情失败和回应不足造成孩子的抑郁状态。

2.2 建立良好的亲子关系

自体客体是被用于服务自体的，因此，足够好的养育者能够让孩子体验到其自体发展的需要是可以得到很好的满足的。良好的养育者可以看到、肯定和回应孩子的力量，并让自己成为孩子完美的仰慕者，从而使孩子发展出镜映自体客体和理想化自体客体；次要养育者或一些伙伴让孩子感受到与他们的相似性，从而使孩子发展出孪生自体客体。当这三个面向的自体客体被孩子逐渐内化为自体结构，便能够支撑并保障孩子自体的正常发展。但是，如果自体客体及其功能未被整合进孩子的人格，则会让孩子体验到自体的虚弱感和无力感，即呈现出情绪低落和丧失对生活热情的抑郁状态。因此，家庭养育者应与孩子建立良好的亲子关系，努力让自己成为孩子良好的自体客体

经验提供者，避免不良的亲子互动损伤孩子的自体感，进而发展为抑郁症。

2.3 创设适当的延迟满足空间

在个体成长早期，养育者（父母）并不可能总是能够满足孩子的需求，适度的、恰到好处的挫折一方面可以帮助孩子认识到自己的局限性和不切实际的幻想，使其在与现实环境的互动中发展出对世界的适应；另一方面可以促进自体客体及其功能转化为孩子内在的心理功能，进而强化孩子的自体内聚性和稳定性^{[29][123]}。因此，家庭养育者（父母）既不应完全满足孩子的所有需求，也不必因为未能满足孩子的需要而担忧焦虑，而要以适当的规则和限制为孩子创设一个延迟满足空间，这样才能避免孩子未来因为遭受更大的挫折而产生自体碎裂，进而陷入自我否定或抑郁状态。

3 自体重建与抑郁症的治疗

在自体心理学的理论框架下，自体重建指的是在分析情境中，咨询师通过治疗性关系重新激活患者早期未满足的自体客体需求，并修复自体发展停滞（自体缺陷），从而实现患者自体内聚性与心理功能自主性的过程。由于自体心理学关注内聚性自体的重建，因此，对于抑郁症的治疗方面，咨询师可以通过共情-内省的同调连接，激活患者被压抑的自体客体移情并使其发生退行，再经由恰好的挫折和诠释作用等技术来修复抑郁症患者脆弱、缺陷性的自体，从而帮助抑郁症患者增强自体感，实现自我接纳与人格成长。

3.1 重视共情-内省的方法以安抚自体

在自体心理学的治疗情境中，共情也称“替代性内省”，指的是咨询师从个人主观参考系去理解患者内在精神现实的方法。科胡特^[30]认为共情是了解另一个人内部经验的工具，是认识的手段，咨询师良好准确的共情既可以收集患者内在体验性的资料，又可以实现情感性回应和心理功能性回应的双重功能。有多项研究证实，积极有效的共情可以有效减轻抑郁症患者的病症^[31-32]。因此，对于抑郁症患者而言，咨询师应超越自身边界，始终以共情、同调的态度与患者工作，让自己浸泡在患者的精神现实的体验中，与其同频共振，这样不仅可以共鸣抑郁症患者因未满足的自恋需要而引发的负性自我体验，达到与患者更快建立共识和增强彼此之间情感联结的目的，也能够让抑郁症患者感受到自己从根本上被理解，从而帮助患者安抚和增强患者虚弱的自体，达到减轻其抑郁症状的目的。

3.2 激活自体客体移情以呈现自体

在自体心理学的临床治疗中，非常重视自体客体及自体客体移情的作用，而自体客体移情是由自体的功能缺陷所引起^[33]。具体而言，以往受到抑制的自体客体需要会发展出缺陷性的自体，这类患者会在安全、共情的咨询情境下发生退行并呈现出不同类型的自体客体移情（镜映移情、理想化移情和密友移情）。患者的自体客体移情具有非常

重要的临床意义^{[14][116]}，一方面，咨询师可以通过移情深入追踪患者的创伤点，有效建立个案概念化；另一方面，咨询师可以在患者的自体客体移情浮现后帮助其移情意识化。所以，患者的自体客体移情为咨询师提供了洞察患者内心世界的窗口，也为咨询师修复患者受损自体、恢复自尊带来了可能性。在抑郁症的治疗中，咨询师可以通过创设共情、安全的环境来激活患者的自体客体移情，咨询师自身暂时先充当患者的自体客体功能提供者，满足其自体客体需要，再进行相应的处理应对。但这里的满足并不是意味着咨询师要一味地夸奖或者满足患者。具体而言，当患者在咨询中呈现出镜映移情时，咨询师要将患者内心压抑的真实体验反馈给患者，帮助他进行精准的理解，患者的感受越被复述、反馈和澄清，其内在感受越凝聚，自体也越凝聚；当患者呈现出理想化移情和孪生移情时，咨询师要保持中立，不打断急于分析，给患者充足的空间表达，允许其在理想化幻想中停留一会，等待理想化的自然褪色。总之，咨询师要善于觉察并积极利用患者在咨询情境中呈现的自体客体移情，在此基础上开展对抑郁症患者受损自体结构的修复工作，这样患者以往受阻的心理成长才可以被完成。

3.3 利用恰到好处的挫折和诠释以修复自体

在临床咨询中，咨询师也不可能总是能够做到无错误的共情回应患者，可能就会随机触碰到患者某个潜意识的创伤点，但由咨询师在无意中制造的这种挫折情境（恰好的挫折）正是修通患者创伤的重要位置。修通患者创伤的过程需要依靠“诠释”这一技术，良好的诠释技术可以实现对患者的潜意识意识化、哀悼患者的需求和欲望，以及帮助其重建自体客体这三种作用。并且，在自体心理学的临床实践中，恰好的挫折和诠释通常是共同发挥作用的，咨询中出现的“恰好的挫折”需要咨询师的诠释来帮助患者进行自体修通，而咨询师的诠释本身也可以为患者提供其需要的适度挫折，从而增长患者的心理结构^{[33][108]}。

因此，当咨询师与抑郁症患者工作时，无须因为偶尔未能准确共情到抑郁症患者的情绪体验或者想法而感到自责，相反，咨询师可以利用这种机会对患者进行同调回应的“补救”来填补抑郁症患者缺陷的自体结构，即咨询师可以对当下的咨询进行回溯与修通来帮助患者发展出各种自体-安抚能力，通过转变内化作用的发生来帮助抑郁症患者逐渐发展出内聚性的自体。

对于抑郁症患者的治疗而言，当其在同调、安全的移情链接作用下发生退行后，咨询师便可以通过恰好的挫折来激活其早期成长中的创伤点，再经由正确的诠释来帮助其自体修复。对抑郁症患者的诠释也需要注重从理解和解释两个部分进行有效处理。在理解的过程中，咨询师要在共情的基础上努力理解抑郁症患者，并重点关注抑郁症患者在其言语及行为背后的内心主观体验；在解释的过程中，咨询师可以对抑郁症患者的移情体验和自恋脆弱性分别进行动力学解释（与当下咨询情境有关）和起源学解释

(抑郁症患者早期经历有关)^{[29][248]}。同时,咨询师需要将共情-内省贯穿诠释的全过程,这是治疗取得成功的关键。最后,在咨询师与患者双方的共同努力下,抑郁症患者会逐渐修通早期的心理困扰,增强内聚、统整性的自体感,从而获得自尊、自我价值和生命意义感。

4 自体心理学治疗抑郁症的价值与展望

抑郁症对个人、家庭和社会造成的高危害性,以及疾病治疗的困难性和高复发性,凸显了对抑郁症进行及时预防和有效治疗的紧迫性。在抑郁症的形成方面,病因学研究显示多种因素会造成个体的抑郁症,而环境因素对抑郁症的影响不容忽视^[5]。在自体心理学的理论视角下,外在环境(如重要养育者)与个体的互动关系深刻影响个体的主观体验-自体感的建立,在此基础上,提出养育者应与个体建立稳定、安全的依恋关系,以共情同调的回应、适度满足的态度对待个体的自体客体需求,以良好的自体客体功能提供者来帮助个体建立内聚性的核心自体,避免因创伤性挫折造成的自体结构缺陷使其发展为抑郁症。

在抑郁症的治疗方面,心理治疗相较于药物治疗对抑郁症的长期改善作用更为明显^[34],但不同的心理治疗对抑郁症的疗效存在一定的差异^[7],而以自体心理学为理论模型进行的抑郁症个案治疗具有良好的效果^[35-36]。与当前主流的 CBT 和 IPT 等方法相较而言,自体心理学往往更深入抑郁症患者的内在精神世界,能触及到人格核心,可以针对患者的自体需要和情感体验做工作;与其他流派的精神分析治疗方法相比,自体心理学从更为人性的角度出发,探究了人的存在本质,揭示了自恋、自体需要和自尊对个体的重要性,也为精神分析治疗领域打开了新视角。总体而言,自体心理学更为温暖和包容,也贴近患者的感受,咨询师可以与抑郁症患者在平等的对话环境中,与其一起探索自我,疗愈自我。通过共情-内省的方法,咨询师能更快地与抑郁症患者进行情感联结,让患者本人体验到自己被深度理解的感受,从而安抚自身;通过自体客体移情,抑郁症患者受损的自体结构(镜映、理想化)可以在咨询情境中再度活化(退行),咨询师暂时的充当患者的自体客体,在挖掘患者创伤点的同时,帮助患者体验到被抚慰、安全的感觉,并将患者的潜意识意识化;咨询师在咨询中不可避免的错误回应(恰好的挫折)会让抑郁症患者发展出自体-安抚能力,使其发生转变性内化,以弥补其自体缺陷;动力学和起源学双重诠释的过程则可以帮助患者修复其当下与咨询师的动力学关系,修通其早期成长带来的自体功能缺陷,帮助患者重建结构上完整、功能上稳定的自体,从而获得自尊、自我接纳与意义感。

然而,目前有关自体心理学模型治疗抑郁症的相关理论、实证干预研究数量较为有限,并且,由于抑郁症疾病本身的复杂性,该理论模型并不可能适用所有类型的抑郁症。因此,未来可以增加在该理论模型视角下对抑郁症治

疗的系统性研究。例如,在理论研究方面,可以从不同发展阶段的自体心理学视角深入揭示抑郁症的形成机制,并提出有效的应对及治疗方法;在实证干预方面,可以将其其他治疗抑郁症的主流心理治疗方法,如 CBT、IPT、BA 与自体心理学的治疗理念进行有机结合,以提高对不同类型及不同年龄群体抑郁症治疗的有效性。

参 考 文 献

- [1] 丁 颖,汪紫滢,李卫东. 抑郁症疼痛加工的行为特点及神经机制[J]. 心理科学进展, 2024, 32(8): 1315-1327.
- [2] 曾子豪,胡义秋,刘双金,等. 学校人际关系与血清素系统多基因累积遗传风险对青少年抑郁的影响[J]. 心理发展与教育, 2025, 41(3): 436-447.
- [3] 李 莉,唐 麟. 成年抑郁症患者非自杀性自伤行为及其动机的影响因素[J]. 实用医学杂志, 2024, 40(4): 466-470.
- [4] 晏克文,张彩营,黄子扬,等. 儿童青少年抑郁症患者自杀未遂与校园欺凌及心理韧性的关系[J]. 中国心理卫生杂志, 2025, 39(5): 416-422.
- [5] 杨 潇,董再全,王 瑜,等. 抑郁症病因学和治疗学的研究进展[J]. 中国科学: 生命科学, 2022, 52(11): 1678-1691.
- [6] 闫紫菱. “时间性情感工作”: 抑郁症休学青少年照顾者的情感积极化管理策略及其逻辑[J]. 当代青年研究, 2025(2): 1-19.
- [7] 章 琪,和 申,李 华. 2022 年美国预防临床服务指南工作组《儿童和青少年抑郁症和自杀风险筛查推荐声明》解读[J]. 中国全科医学, 2025, 28(15): 1823-1830.
- [8] 李英仁,刘惠军,杨 青. 行为激活疗法: 一种简易而经济的抑郁症干预措施[J]. 中国临床心理学杂志, 2019, 27(4): 854-858.
- [9] 寻知元. 从精神医学角度看“空心病”现象[J]. 医学与哲学, 2023, 44(9): 40-43.
- [10] D'AGOSTINO A, PEPI R, ROSSI MONTI M, et al. The feeling of emptiness: A review of a complex subjective experience[J]. Harv Rev Psychiatry, 2020, 28(5): 287-295.
- [11] 张晓燕,原建华. 焦虑抑郁情绪对高血压患者血压控制、血清 Hcy 水平和生活质量的影响[J]. 国际精神病学杂志, 2025, 52(2): 579-582.
- [12] 刘春梅,刘安诺,刘梦晨. 老年人代际支持及抑郁对其社会隔离的影响[J]. 护理研究, 2025, 39(8): 1267-1271.
- [13] 科胡特. 自体的分析[M]. 刘慧卿,林明雄,译. 北京: 世界图书出版公司, 2015: 99.
- [14] 徐 钧. 徐钧自体心理学入门[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2022.
- [15] 周惠至,杨舒然,韩 冬,等. 家庭动力学特征和负性生活事件与青少年抑郁症状的相关性分析[J]. 解放军医学杂志, 2024, 49(12): 1360-1365.
- [16] 科胡特. 精神分析治愈之道[M]. 瞿 非,曲清和,张 帆,译. 重庆: 重庆大学出版社, 2016: 38.
- [17] HUPRICH S K, NELSON S M. Malignant self-regard: Accounting for commonalities in vulnerably narcissistic, depressive, self-defeating, and masochistic personality disorders[J]. Compr Psychiatry, 2014, 55(4): 989-998.
- [18] 宛立鹏. 孤独感、社会隔离与抑郁症发病的关联[D]. 济南: 山东大学, 2023.
- [19] 吕伟红. 科胡特自体心理学理论对心理治疗的启示与助益[J]. 学术交流, 2014(10): 49-53.
- [20] 魏宏波. 从一种理论走向多种取向[D]. 南京: 南京师范大学, 2011.
- [21] ABELA J R Z, HANKIN B L. Handbook of Depression in Children and Adolescents[M]. New York: The Guilford Press, 2008: 79.
- [22] 汤佳怡,付成好,徐 慰. 青少年家庭功能对抑郁和社交焦虑的影响: 公正世界信念的中介作用[J]. 心理发展与教育, 2025(5): 701-709.

(下转第 76 页)

[EB/OL]. (2025-04-04)[2025-05-05]. https://data.bnf.fr/11925235/george_soulie_de_morant/#.

[5] The Nobel Prize Nomination Archive[EB/OL]. [2025-05-05]. <https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show.php?id=9361>.

[6] 陈义海. 对明清之际中西异质文化碰撞的文化思考[D]. 苏州: 苏州大学, 2002.

[7] 叶 晓, 陈云慧, 陈 骥, 等. 中医药海外传播的文化变迁机制研究[J]. 医学与哲学, 2021, 42(22): 66-69.

[8] Bibliothèque Nationale de France. Judith Gautier: 1845-1917[EB/OL]. (2025-04-04)[2025-05-05]. https://data.bnf.fr/11904428/judith_gautier/.

[9] Encyclopédie Wikimonde. George Soulié de Morant[EB/OL]. (1970-01-01)[2025-05-05]. https://wikimonde.com/article/George_Souli%C3%A9_de_Morant.

[10] SOULIÉ G. Chinese Acupuncture[M]. Brookline: Paradigm Publications, 1994: 7.

[11] Britannica. Théophile Delcassé[EB/OL]. (2025-02-25)[2025-05-05]. <https://www.britannica.com/biography/Theophile-Delcasse>.

[12] CANDELISE L. George Soulié de Morant: The first French expert in acupuncture[J]. Rev Synth, 2010, 131(3): 373-399.

[13] SOULIÉ G. Soun Iat-Sènn[M]. Paris: Gallimard, 1932.

[14] Gera. Acupuncture preuves & Pratiques[EB/OL]. (2024-11-01)[2025-05-05]. <https://gera.fr/>.

[15] Acupuncture-medicale. L'Acupuncture Médicale en France[EB/OL]. (2025-03-06)[2025-05-05]. <https://acupuncture-medic.fr/>.

[16] The Internet Archive. Précis de la vraie acupuncture chinoise: Doctrine, diagnostic, thérapeutique[EB/OL]. (2023-04-27)[2025-05-05]. <https://archive.org/details/precisdelavraiea0000soul>.

[17] SOULIÉ G. L'Acupuncture chinoise[M]. Paris: Trédaniel, 1979: 7-8.

[18] CANDELISE L. Construction, acculturation et diffusion de l'«acupuncture traditionaliste française» au XXe siècle[J]. Doc Hist Tech, 2008, 16: 76-88.

[19] 庞熠超, 王 涵, DE MEYER E, 等. 苏烈与保尔·费雷罗雷斯首篇论文《20 世纪中国针灸和现代反射疗法》对针灸西传影响的研究[J/OL]. 中国针灸, 2025(2025-02-21)[2025-05-05]. <http://doi.org/10.13703/j.0255-2930.20240923-k0001>.

[20] CANDELISE L. Diplomacy, Empire and Medicine: The Construction of French Acupuncture[M]. Paris: Editions De Bocard, 2017: 295.

[21] NGUYEN J. La Réception De L'Acupuncture en France: Une biographie revisitée de George Soulié de Morant: 1878-1955[M]. Paris: Editions L'Harmattan, 2012: 161-162.

[22] 王 涵, 麦丽娜, 庞熠超, 等. 民国时期中法针灸名家方慎盒与苏烈往来通信研究[J]. 中国针灸, 2025, 45(6): 834-840.

[23] 曾睿林, 吴 凯. 法国副领事苏烈与针灸金针[J]. 中国针灸, 2019, 39(6): 651-654.

[24] 曾睿林, 吴 凯, 戴 翥, 等. 中医西学博物馆: 中医在西方的纪实[J]. 中华医史杂志, 2021(5): 313-320.

[25] JACQUEMIN J. George Soulié de Morant, sa vie, son oeuvre[J]. Revue Francaise d'Acupuncture, 1985, 42: 9-31.

[26] 曾睿林. 对“法国针灸之父”苏烈针灸文物的研究[D]. 昆明: 云南中医药大学, 2021.

[27] GEOFFROY D D. L'Acupuncture en France au XIXe siècle[M]. Sainte-Ruffine: Maisonneuve, 1986: 169-173.

收稿日期: 2023-08-24

修回日期: 2025-05-11

(本文编辑: 王德顺)

(上接第 57 页)

[23] 杨 婧, 李颖波, 彭 洪, 等. 青少年抑郁症患者负性情绪体验的质性研究[J]. 心理月刊, 2022, 17(24): 119-121.

[24] 郑童萱. 儿童期创伤与抑郁症状的关联机制: 来自嗅觉功能的初步证据[D]. 上海: 华东师范大学, 2024.

[25] MANDELLI L, PETRELLI C, SERRETTI A. The role of specific early trauma in adult depression: A meta-analysis of published literature. Childhood trauma and adult depression[J]. Eur Psychiatry, 2015, 30(6): 665-680.

[26] 张 健. 理想自我在自恋产生中的作用[D]. 济南: 山东大学, 2017.

[27] 科胡特. 自我的重建[M]. 许豪冲, 译. 北京: 世界图书出版公司, 2015: 149.

[28] 刘斗艳. 教养方式与青少年抑郁的关系: 父母共情的调节作用与干预研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2023.

[29] 蔡 飞. 自身心理学: 科赫特研究[M]. 福州: 福建教育出版社, 2008.

[30] KOHUT H. The curve of life: Correspondence of Heinz Kohut, 1923-1981[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1994: 11.

[31] 付小静, 成芳芳, 王进胜. 共情干预模式在剖宫产产妇中的应用效果及对产后情绪状况及抑郁症发生情况的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2024, 9(17): 149-152.

[32] 黄清清. 共情护理对青少年抑郁症患者心理状况、生活质量的影响分析[J]. 宜春学院学报, 2024, 46(6): 83-86.

[33] KOHUT H. How Does Analysis Cure [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

[34] SIMON G E, MOISE N, MOHR D C. Management of depression in adults: A review[J]. JAMA, 2024, 332(2): 141-152.

[35] POTIK D. Self psychology conceptualization of postpsychotic depression and recovery among paranoid schizophrenic patients[J]. Bull Menninger Clin, 2014, 78(1): 70-86.

[36] 哈格曼, 保 罗, 齐默尔曼. 精神分析的新发展: 主体间自体心理学[M]. 王贺春, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2023: 135.

收稿日期: 2025-03-27

修回日期: 2025-06-04

(本文编辑: 刘利丹)